

HÉMATOLOGIE

Dr.KHERBA_N

HÉMATOLOGIE

Adénolymphite mésentérique

Adénopathie cervicale

Anémie férriprive

Anémie par carence en facteurs antipernicieux

Bétathalassémie

Drépanocytose

Hématémèse

Syndrome hémorragique

Thrombopénie

Adénolymphite mésentérique

Clinique :

Infection majoritairement virale qui se manifeste par l'inflammation douloureuse d'un ou plusieurs ganglions lymphatiques au niveau du péritoine abdominal, enfant +++

Pathologie bénigne (post infection, résolution spontanée)

Examen ORL, respiratoire

■ Échographie abdominale (étiologie fréquente d'occlusion par invagination)

Traitement : symptomatique

Antispasmodique :

 Débridat sirop 1cam 3/j

Ou Spasfon lyoc 1lyoc en sublingual 3/j

2 Antalgique : Paracétamol

3 Zinc sirop

■ Si suspicion d'origine bactérien + fièvre ↗ :

Augmentin pdt 10j

Adénopathie cervicale

- Interrogatoire :

ATCD, début, signes associés, notion de Tuberculose

- Examen clinique : état général, coloration, d'autres localisations, palpation (caractères), signes d'infection (Rubéole, Oreillons..)

- Examen ORL

- Syndrome tumoral : SPM/HPM=> Leucémie aiguë

- Bilan :

- FNS (Hyperlymphocytose/cytopénie)

- CRP/VS

- Hépatique

- ASLO : Strepto

- TLT

- Échographie
- IDR à la Tuberculine
- Frottis sanguin
- Cytoponction

 Critères d'alerte : Biopsie + explorations approfondies :

- >2_3cm, dure, fixe
- Évolution >4_6sem

ADP >1cm :

1 Aigue : Infectieux +++ (ORL..)

Traitement selon la cause

Éruptions, toux, cause virale..

2 Chronique >3sem : TBC/Cancer

Palpation : autres ADP, SPM, HPM

- FNS/Frottis sanguin=> Leucémie aiguë

- TLT : ADP médiastinaux, caverne tuberculose
- Sérologie : Hépatites, HIV, EBV, CMV, Rubéole, Oreillons

■ Examen ORL : dysphonie, épistaxis, obstruction nasale => Cancer du cavum ou larynx

 Orientation ORL pour une Biopsie

■ Infectieux : Rovamycine sirop ou cp 3/j pdt 10j
Contrôle après 15j

Anémie ferriprive

● Clinique :

Anémie microcytaire hypochrome

■ Syndrome anémique :

Pâleur cutanéomuqueuses, asthénie

Effort : dyspnée, tachycardie, palpitations,
lipothymie, vertiges

Souffle d'IA, œdème des membres inférieurs

■ Signée de sideropénie : ongles minces, aplatis,
cassants, cheveux secs et cassants

Perlèche, glossite, ictère, troubles digestifs,
Infections...

↘ Hb : Anémie

■ NNE : 13.5g/dl

■ 12ans : <11.5g/dl

■ Homme : <13g/dl

■ Femme : <12g/dl / ■ Femme enceinte : <10g/dl

■ $80 < \text{VGM} < 100$

Micro < Normo < Macrocytaire

■ < 120.000 : arégénérative => Central

■ > 120.000 : régénérative => Périphérique (hémolyse, hémorragie)

■ Anémie microcytaire hypochrome
arégénérative :

■ Carence en fer => Ferritinémie $\searrow$

■ Inflammatoire => Ferritinémie $\nearrow$, VS/CRP, fibrinogène

■ Sidéroblastique => Ferritinémie, Méylogramme

■ Anémie microcytaire hypochrome
régénérative :

■ Bétathalassémie => électrophorèse de Hb

- Anémie normocytaire macro ou hypochrome régénérative :

- Hyperhémolyse chronique => hyperbilirubinémie, test de Coombs

- Hémorragie récente

- Anémie macrocytaire normochrome arégénérative :

- Carence en facteurs anti pernicioeux (B12 et Ac folique)

- Insuffisance médullaire

↘ Hb + ↘ VGM : Anémie par carence en fer

↘ Hb + ↗ VGM : Anémie par carence en B9B12

Hb normale + ↗ VGM : Hypothyroïdie

- ✓ Traitement selon le taux Hb : 4_6mois

Hb<7 : Transfusion sanguine

■ Bilan : 

■ FNS/Ferritinémie/Fer sérique

■ Taux de réticulocytes

✓ Traitement Curatif :

>30kg >10ans : 100_200mg de Fer métal par jour

Ou 2_3mg/kg/j

■ Adulte : Fumacur en dehors des repas

■ >30kg environ 10ans : 100_200mg/j

Cp 200mg 1cp 2/j pdt 2_3mois jusqu'à normalisation de FNS

Cp 200mg 1cp 1/j pdt 1_2mois jusqu'à normalisation de Ferritinémie (contrôle 2sem après fin de traitement)

■ 6_10ans : Tardyferon 1cp/j Puis 1cp/2j

■ <6ans : Ferrum gtt 4gtt/kg/j Puis 2gtt/kg/j

■ Femme enceinte  : Zanitra plus 0.4mg

Ferrosanol gyn ou Tothéma

Ou Triferfol cp 1cp/j le matin à jeun

Ou Fumafer cp 200mg 2mg/kg/j 120mg/j

+ Vit C (facilite l'absorption) cp 250mg 1cp/j

Geofer amp 1amp 2/j => complément
alimentaire

■ Ferrosanol gyn (fer + ac folique + vit C)

Préventif : 1gel/j => grossesse et allaitement

Curatif : 1gel 2/j pdt 1mois puis 1gel/j pdt 3mois

■ Triferfol (ac folique +++) 1gel/j préventif

1gel 3/j pdt 3mois

■ Trifer 1_2amp/j pdt 3_6mois

■ Fumacur >10ans 200mg 1cp/j

■ Enfant 🐼

Anémie par carence en fer touche surtout les enfants âgés de 9 à 36 mois, car ils ont épuisé, après l'âge de 6 mois.

■ Supplémentaire en fer jusqu'à la normalisation de Hb au moins 2 mois (4_6 mois).

2_3mg/kg/j

Fumacur cp 2cp 2/j pdt 2 mois pour corriger Hb.

Puis 4 mois pour restaurer les réserves :

1cp 2/j.

■ Surveillance de taux Hb

+ Traitement de l'étiologie

■ Fumacur : >10ans

■ Ferrum gtt : <2ans

Curative : 4gtt/kg/j pdt 2 mois

Préventive : 2gtt/kg/j

■ Selo fer 50 : 2_5ans

Curative : 1ml/kg/j

Préventive : 0.5ml/kg/j

■ Selo fer 100 : >5ans

Curative : 10_15ml/j

Préventive : 5ml/j

■ Enfant : 8_10mg/kg/j de fer métal

■ Adulte : 2_3mg/kg/j de fer métal => 2cp 2/j

■ Fumafer au milieu des repas.

✓ **Forme orale :**

■ Comprimés :

■ Fumarate ferreux (Fumafer[®]) 1cp à 200mg = 66mg de fer métal.

■ Sulfate ferreux (Tardyféron[®]) contient 80mg de fer métal par comprimé

- Férrrosanol Duodénal (Cp 200mg) qui contient 66mg de fer métal

- Poudre : sous forme de Fumarate ferreux chocolaté : 1càc = 33mg fer métal.

- Sirop : Ferrostrane : 1càc = 33mg de fer métal.

- ☑ Forme injectable : réservée aux malades présentant soit :

- Une intolérance digestive à la forme orale

- Malabsorption

- Seul fer injectable disponible : Venofer par voie IV à usage hospitalier.

- Le taux d'Hb se corrige en 2mois et les réserves se restaurent en 6mois

Âge	Hémoglobine (g/l)	VGM (fl)	Ferritine (µg/l)
0-7 jours	135-200	95-115	153-1092
8-30 jours	100-160	85-100	247-692
1-3 mois	95-145	85-100	148-744
4-9 mois	95-135	75-95	21-240
9-24 mois	105-135	75-85	10-168
2-16 ans	115-150	77-85	10-99
>16 ans (sexe féminin)	120-160	78-95	18-103
>16 ans (sexe masculin)	130-170	78-95	16-213

Anémie par carence en facteurs antipernicieux

● Clinique : Anémie macrocytaire normochrome mégaloblastique arégénérative

- Syndrome anémique : Pâleur cutanéomuqueuses, subictère, palpitations, dyspnée, asthénie, lipothymie
- Syndrome neuropsychique (v B12) : Sclérose
Paresthésie, crampes, troubles de sensibilité profonde
Céphalées, bourdonnement d'oreilles, vertiges, scotome
- Syndrome infectieux
- Glossite de Hunter : langue lisse, dépaillée, vernissée
- Signes digestifs : dyspepsie, épigastralgies, anorexie, diarrhée (Malabsorption)

- Si non Avis gastro=> Maladie de Biermer (Fibroscopie)
- Vit B9 : Rechercher une prise des anti convulsives

Déficit en B9B12

Hb↘

- NNE : 13.5g/dl
- 12ans : <11.5g/dl
- Homme : <13g/dl
- Femme : <12g/dl
- Femme enceinte : <10g/dl

- Bilan : 
- Dosages des Vit B9B12
- Si non test thérapeutique
- Si non Frottis sanguin + Médullogramme
- FNS

■ Bilirubine non conjugué ↗

■ Fer sérique ↗

■ LDH ↗

■ Test thérapeutique à la Vit B12 : 1 micro g/j en IM pdt 3j

AC folique 100 micro g/j per os pdt 3j

Crise réticulocytaire après 7j

✓ Traitement : 2 mois

1 B12 1000 micro gama 1j/2 pdt 20j 10 inj en IM

Ou 1 inj/j pdt 5j puis 1 inj/sem pdt 1 mois

Ou Oral :

Attaque : 1 amp/j pdt 15j _ 1 mois

Entretien : 1 amp tous les 10j

2 B9 Zanitra cp 5mg 1cp 2/j pdt 2mois

Adulte : 20mg/j

Enfant : 10mg/j

⇒ FNS après 6sem de traitement

3 Acide folinique 10_50mg en IV

Bétathalassémie majeure

Maladie de Cooley

● Clinique :

- Consanguinité
- Dès l'âge de 6mois
- Retard staturo pondéral
- Triade hémolytique : Pâleur, ictère, splénomégalie
- Dysmorphie crâniofaciale par déformations osseuses, faciès mongoloïde, bosse frontale, implantation anormale des dents..
- Biologie : Anémie microcytaire hypochrome peu régénérative $Hb < 7g/dl$
- Confirmer par : Taux de réticulocytes

- Electrophorèse de Hb=> absence d'Hb anormale

Absence Hb A(B0) ou taux faible de Hb A(B+)

Hb A2 variable

- Anisopoikilocytose avec signes de régénération

 CAT :

- Hygiène et prévention des infections

- Supplémentation en Ac folique 5_10mg/j 15j par mois

- Transfusion

- Chélateur de fer

Drépanocytose

● Clinique:

Anomalie de structure des chaînes β de Hb=> HbS

- Retard pondéral plus marqué que le retard statural
- Dysmorphie crâniofaciale
- Crises vaso-occlusives: dues aux microthromboses déclenchées par: hypoxie, froid, déshydratation, infections=> douleurs osseuses et articulaires, signes respiratoires, fièvre..
- Crise hémorragique
- Éliminer un syndrome thoracique:
Fièvre, détresse respiratoire, douleur, foyer de pneumopathies
=>2l/m²

- Biologie: Anémie normocytaire normochrome régénérative
- Frottis sanguin: Drépanocytes
- Electrophorèse de Hb: HbS>80%, HbA absente

CAT:

- Éviction des facteurs qui déclenchent la crise drépanocytaire
- Vaccination
- ATB préventif
- Supplémentation en Ac folique
- Crise VO:
- Repos
- Hydratation: Hyperhydratation 3l/m² sans dépasser 3l/24h

Schéma de 6h à renouveler si persistance de crise:

1/3 Bicarbonaté en 2h

2/3 glucosé en 4h

Si non SS puis SG puis SS

■ Surface corporelle = $4p + 7/90 + p$

■ Bilan: 

■ FNS

■ CRP

■ Réchauffement

■ O2 thérapie

■ Antalgique Prodaf puis Voltarene en IM voir un Morphinique si nécessaire

■ Rx si douleur pour éliminer une fracture

■ Crise hémorragique: Transfusion

Hématémèse

- Stabilisé le patient: Fc, PA/VVP
- Corrigé Hb: si Hb < 8  transfusion de 2 culot globulaire
- Prise de TA: si  remplissage
- Dycinone 1amp

- Bilan 
- FNS
- TP
- Glycémie à jeûn
- Urée/Créat
- ASAT/ALAT
- Ionogramme
- Groupage

- Soluté de remplissage ou une bonne réhydratation
- Mopral 40mg/12h

■ Si + Méléna: Duphalac pour éliminer le sang digéré

■ Si stabilisation  FOGD

Syndrome hémorragique

● Clinique :

- Purpura : ne s'efface pas à la vitro pression
- Pétéchies, échy-moses, vibices

Epistaxis, gingivorragies, bulles hémorragiques..

■ Bilan :

- FNS
- Hémostase (TP/TCK/TQ/fibrinogène)

Thrombopenie

● Clinique :

- Syndrome hémorragique <30.000
- Cutané : pétéchies, écouchymoses, vibices
- Muqueuse : Épistaxis, gingivorragies, bulles endo buccales
- Viscérale : Hémoptysie..
- Normal : $150.000_450.000/mm^3$

- Rechercher les signes de gravité :
- Manifestations hémorragiques CM : purpura pétéchiail diffus, écouchymoses spontanées, épistaxis, gingivorragies, hématurie, ménométrorragies
- Signes infectieux ou état septicémique.
- Présence d'une HSPM

- Devant tout AEG sans cause évidente penser à une maladie auto-immune

- Refaire un prélèvement sur tube citraté pour confirmer la Thrombopénie

- Bilan : 

- FNS : Thrombopénie

- CRP/VS

- TGO/TGP

- CU

- Sérologie : Hépatite A/EBV/CMV

- Hémostase : TP/TCK/fibrinogène

- Frottis sanguin : confirme le diagnostic

- Médullogramme : central ou périphérique

 Avis Hématologie

❌ CI : AINS, Aspirine, anticoagulants,
antiagrégants plaquettaires, injections IM,
avulsions dentaires